

Quellen zum Video „Das Doppelgänger-Syndrom: Warum dein Gehirn deine Familie für Betrüger hält“

17 QUELLEN · STAND 10. OKTOBER 2026 · YOUTUBE.COM/@INTRA_DE

Wir verwenden Originalarbeiten und Fachaufsätze. Gelesen haben wir in der Regel die veröffentlichte Zusammenfassung der Arbeit; die Erstbeschreibung von 1923 lag uns als Scan des Sitzungsberichts vor. Die rechte Spalte nennt, was die jeweilige Quelle im Video belegt.

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q1	J. Capgras, J. Reboul-Lachaux: L'illusion des « sosies » dans un délire systématisé chronique. Sitzungsbericht der Société clinique de médecine mentale vom 10.1.1923, Annales médico-psychologiques 81 (1923), 186–188. Scanned in der BIU Santé Paris ORIGINALARBEIT (SITZUNGSBERICHT)	Erstbeschreibung: Patientin verwandelt seit etwa zehn Jahren jeden Menschen ihrer Umgebung, auch Mann und Tochter, in Serien von Doppelgängern; keine Verwechslung, Wahrnehmung ungestört; ein Gefühl von Fremdheit an der Stelle des Gefühls von Vertrautheit; ausgeprägtes Misstrauen und Achten auf kleinste Einzelheiten
Q2	R. M. Bauer: Autonomic recognition of names and faces in prosopagnosia. Neuropsychologia 22 (1984), 457–469. DOI 10.1016/0028-3932(84)90040-x ORIGINALARBEIT	Gesichtsblinder Patient rät bei Familienfotos auf Zufallsniveau, seine Hautleitfähigkeit unterscheidet aber den richtigen Namen
Q3	D. Tranel, A. R. Damasio: Knowledge without awareness: an autonomic index of facial recognition by prosopagnosics. Science 228 (1985), 1453–1454. DOI 10.1126/science.4012303 ORIGINALARBEIT	Zwei gesichtsblinde Patienten: starke Hautreaktionen auf früher bekannte Gesichter, die sie nicht erkennen; keine auf fremde; Erkennen über andere Sinne bleibt
Q4	H. D. Ellis, A. W. Young: Accounting for delusional misidentifications. British Journal of Psychiatry 157 (1990), 239–248. DOI 10.1192/bjp.157.2.239 THEORIEARBEIT	Capgras als „Spiegelbild“ der Gesichtsblindheit: der Weg, der verdecktes Erkennen trägt, ist gestört
Q5	H. D. Ellis, A. W. Young, A. H. Quayle, K. W. de Pauw: Reduced autonomic responses to faces in Capgras delusion. Proceedings of the Royal Society B 264 (1997), 1085–1092. DOI 10.1098/rspb.1997.0150 ORIGINALARBEIT	Fünf Capgras-Patienten: kein Unterschied der Hautreaktion zwischen vertrauten und fremden Gesichtern; Reaktion auf Töne normal; zwei Vergleichsgruppen
Q6	W. Hirstein, V. S. Ramachandran: Capgras syndrome: a novel probe for understanding the neural representation of the identity and familiarity of persons. Proceedings of the Royal Society B 264 (1997), 437–444. DOI 10.1098/rspb.1997.0062 ORIGINALARBEIT (EINZELFALL)	Patient D. S.: hält Eltern für Betrüger, wenn er sie sieht, nicht am Telefon; Hautreaktion auf Fotos der Eltern nicht größer als auf Fremde
Q7	I. Reid, A. W. Young, D. J. Hellawell: Voice recognition impairment in a blind Capgras patient. Behavioural Neurology 6 (1993), 225–228. DOI 10.3233/ben-1993-6409 ORIGINALARBEIT (EINZELFALL)	Blinde Patientin hält ihre Katze für eine übelwollende Kopie; gestörtes Erkennen vertrauter Stimmen

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q8	D. Tranel, H. Damasio, A. R. Damasio: Double dissociation between overt and covert face recognition. <i>Journal of Cognitive Neuroscience</i> 7 (1995), 425–432. DOI 10.1162/jocn.1995.7.4.425 ORIGINALARBEIT	Vier Patienten mit Schäden an der Unterseite des Stirnhirns: erkennen Gesichter normal, keine unterscheidende Hautreaktion; zwei getrennte Systeme
Q9	M. Coltheart, R. Langdon, R. McKay: Schizophrenia and monothematic delusions. <i>Schizophrenia Bulletin</i> 33 (2007), 642–647. DOI 10.1093/schbul/sbm017 . Volltext bei PMC ÜBERSICHTS- UND THEORIEARBEIT	Zwei-Faktoren-Theorie: fehlende Körperreaktion allein reicht nicht (Patienten aus Q8 haben keinen Wahn); zweiter Faktor ist eine gestörte Prüfung von Überzeugungen, vermutet im rechten Stirnhirn, genaue Stelle unbekannt
Q10	R. R. Darby, S. Laganieri, A. Pascual-Leone, S. Prasad, M. D. Fox: Finding the imposter: brain connectivity of lesions causing delusional misidentifications. <i>Brain</i> 140 (2017), 497–507. DOI 10.1093/brain/aww288 ORIGINALARBEIT	17 Fälle mit einzelner Hirnverletzung: alle 17 Stellen verbunden mit einer Region für Vertrautheit, 16 von 17 mit rechtem Stirnhirn (Verletzung von Erwartungen)
Q11	K. A. Josephs: Capgras syndrome and its relationship to neurodegenerative disease. <i>Archives of Neurology</i> 64 (2007), 1762–1766. DOI 10.1001/archneur.64.12.1762 RÜCKBLICKENDE AUSWERTUNG	47 Fälle einer Klinik: 81 % mit neurodegenerativer Krankheit, am häufigsten Lewy-Körper-Krankheit
Q12	M. Harciarek, A. Kertesz: The prevalence of misidentification syndromes in neurodegenerative diseases. <i>Alzheimer Disease and Associated Disorders</i> 22 (2008), 163–169. DOI 10.1097/wad.0b013e3181641341 ORIGINALARBEIT	Verkennungen bei 15,8 % der Alzheimer- und 16,6 % der Lewy-Körper-Patienten, am häufigsten als Capgras-Wahn
Q13	P. Salvatore u. a.: Capgras' syndrome in first-episode psychotic disorders. <i>Psychopathology</i> 47 (2014), 261–269. DOI 10.1159/000357813 ORIGINALARBEIT	73 von 517 Patienten mit erster Psychose (14,1 %)
Q14	C. Pandis, N. Agrawal, N. Poole: Capgras' delusion: a systematic review of 255 published cases. <i>Psychopathology</i> 52 (2019), 161–173. DOI 10.1159/000500474 SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT (GEGENREDE)	258 Fälle: auch Gegenstände betroffen, mehrere Doppelgänger, Aggression in beiden Gruppen; das Bild ist uneinheitlicher, als die Modelle annehmen
Q15	V. Bell u. a.: Uncovering Capgras delusion using a large-scale medical records database. <i>BJPsych Open</i> 3 (2017), 179–185. DOI 10.1192/bjpo.bp.117.005041 ORIGINALARBEIT (GEGENREDE)	84 Fälle aus 250.000 Akten: in 25 % auch nicht nahestehende Personen betroffen; kein Vorwiegen rechtsseitiger Schäden; „vielfältiger, als die Modelle annehmen“
Q16	A. W. Young, I. Reid, S. Wright, D. J. Hellawell: Face-processing impairments and the Capgras delusion. <i>British Journal of Psychiatry</i> 162 (1993), 695–698. DOI 10.1192/bjp.162.5.695 ORIGINALARBEIT	Der Wahn als Versuch des Patienten, sich zu erklären, warum Vertrautes keine Gefühlsbedeutung mehr hat

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q17	D. Bourget, L. Whitehurst: Capgras syndrome: a review of the neurophysiological correlates and presenting clinical features in cases involving physical violence. Canadian Journal of Psychiatry 49 (2004), 719–725. DOI 10.1177/070674370404901102 – dazu R. Walfisch u. a.: First-episode psychosis and violence in Capgras syndrome. Cognitive Neuropsychiatry 30 (2025), 295–304. DOI 10.1080/13546805.2025.2571120 ÜBERSICHT; FALLSERIE	Gewalt gegen den vermeintlichen Betrüger kommt vor; in einem Teil der Fälle verschwand der Wahn unter Behandlung

Fehler gefunden? Schreib uns: Studio_Intra@hotmail.com